Situación epidemiológica de la leishmaniasis en Amazonas a la SE 35-2026

I. Introducción

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por vectores, causada por protozoarios del género Leishmania y transmitida al ser humano por la picadura de flebótomos infectados. En el Perú, la enfermedad es endémica y se presenta principalmente en zonas de selva y ceja de selva, donde intervienen condiciones ecológicas, socioambientales y ocupacionales (1,2).

Clínicamente, la enfermedad puede presentarse en formas cutánea y mucocutánea. La forma cutánea es la presentación más frecuente; la forma mucocutánea, aunque menos común, puede producir secuelas funcionales y estéticas permanentes (1).

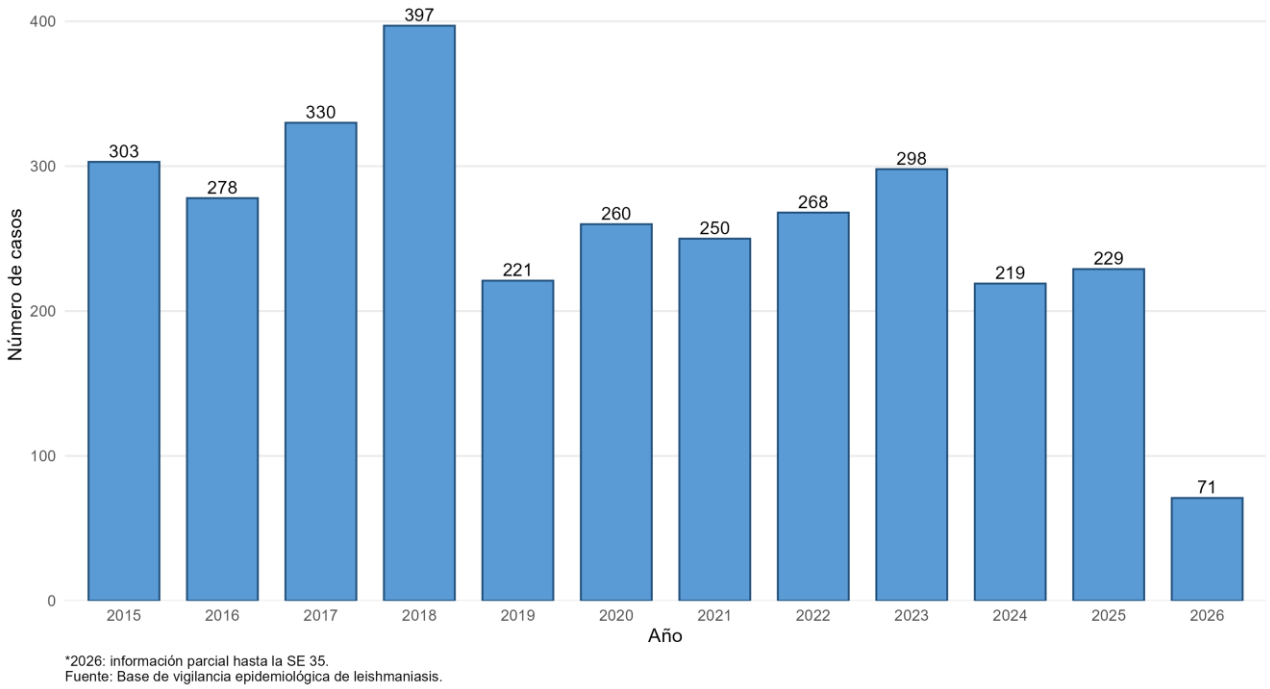
En Amazonas, el análisis de la vigilancia epidemiológica muestra presencia sostenida de casos durante el periodo 2015-2025, con variación interanual. El presente boletín describe la situación epidemiológica de la leishmaniasis en el departamento hasta la semana epidemiológica (SE) 35 de 2026, con énfasis en magnitud, tendencia, distribución territorial, características de los casos y elementos de vigilancia y respuesta.

II. Situación epidemiológica

Hasta la SE 35-2026 se registraron 71 casos de leishmaniasis en Amazonas. Todos correspondieron al diagnóstico B55.1 (leishmaniasis cutánea); según clasificación diagnóstica, 66 casos (93,0 %) fueron confirmados y 5 (7,0 %) probables. La tasa de incidencia acumulada departamental fue de 16,5 casos por 100 000 habitantes, considerando una población proyectada de 430 305 habitantes.

Los casos se distribuyeron en 28 distritos de las siete provincias del departamento. La mayor carga se registró en La Jalca con 17 casos, seguida de Río Santiago con 7 casos; asimismo, se observó marcada heterogeneidad en la incidencia distrital.

Casos de leishmaniasis por año, Amazonas, 2015-2026*



*2026: información parcial hasta la SE 35. Última SE con casos registrados: SE 33. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis, Amazonas.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

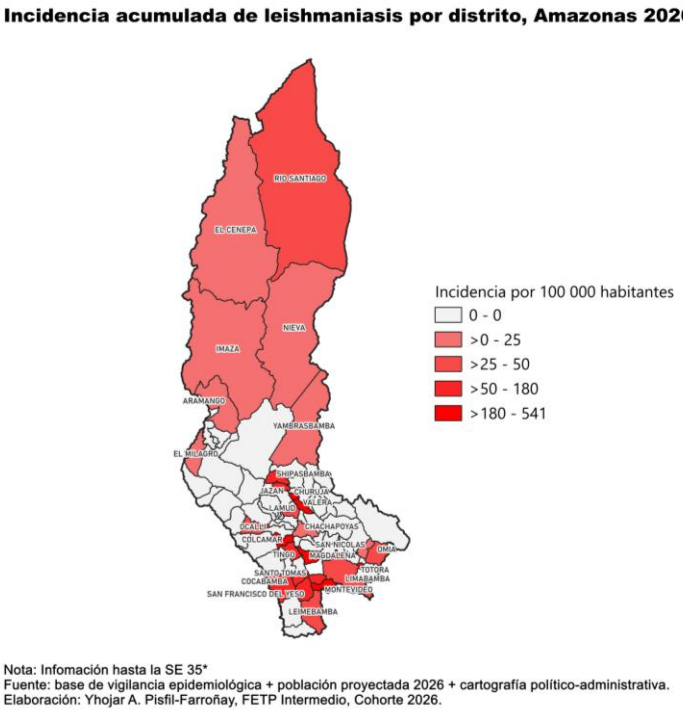
Tabla 1. Casos de leishmaniasis en distritos seleccionados según magnitud e incidencia, Amazonas 2026*

Provincia	Distrito	N.° casos	% del total	TIA por 100 mil hab.
CHACHAPOYAS	La Jalca	17	23,9	541,4
CONDORCANQUI	Río Santiago	7	9,9	35,5
BONGARÁ	Jazán	4	5,6	54,1
BAGUA	Imaza	4	5,6	11,4
CHACHAPOYAS	Chachapoyas	3	4,2	7,1
CHACHAPOYAS	Mariscal Castilla	3	4,2	179,1
LUYA	Cocabamba	3	4,2	162,9
LUYA	Colcamar	3	4,2	182,7
LUYA	Santo Tomás	3	4,2	113,1
RODRÍGUEZ DE MENDOZA	Omia	3	4,2	28,7
BONGARÁ	Shipasbamba	2	2,8	112,7
BONGARÁ	Valera	2	2,8	303,5
CHACHAPOYAS	Magdalena	2	2,8	224,7
RODRÍGUEZ DE MENDOZA	Totora	1	1,4	354,6
BONGARÁ	Churuja	1	1,4	349,7
CHACHAPOYAS	Montevideo	1	1,4	224,7
LUYA	San Francisco del Yeso	1	1,4	150,8
LUYA	Tingo	1	1,4	71,7
RODRÍGUEZ DE MENDOZA	Limabamba	1	1,4	46,6
LUYA	Lamud	1	1,4	44,2

***Información hasta la SE 35-2026. Se presentan distritos con valores de incidencia previamente validados en el análisis. TIA: tasa de incidencia acumulada por 100 000 habitantes. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis y población proyectada 2026.**

La Jalca concentró el 23,9 % de los casos registrados y presentó la mayor TIA distrital (541,4 por 100 000 habitantes). También destacaron Totora, Churuja y Valera por tasas superiores a 300 por 100 000 habitantes, aunque con menor número absoluto de casos. Esto evidencia que la priorización territorial debe considerar conjuntamente magnitud e incidencia.

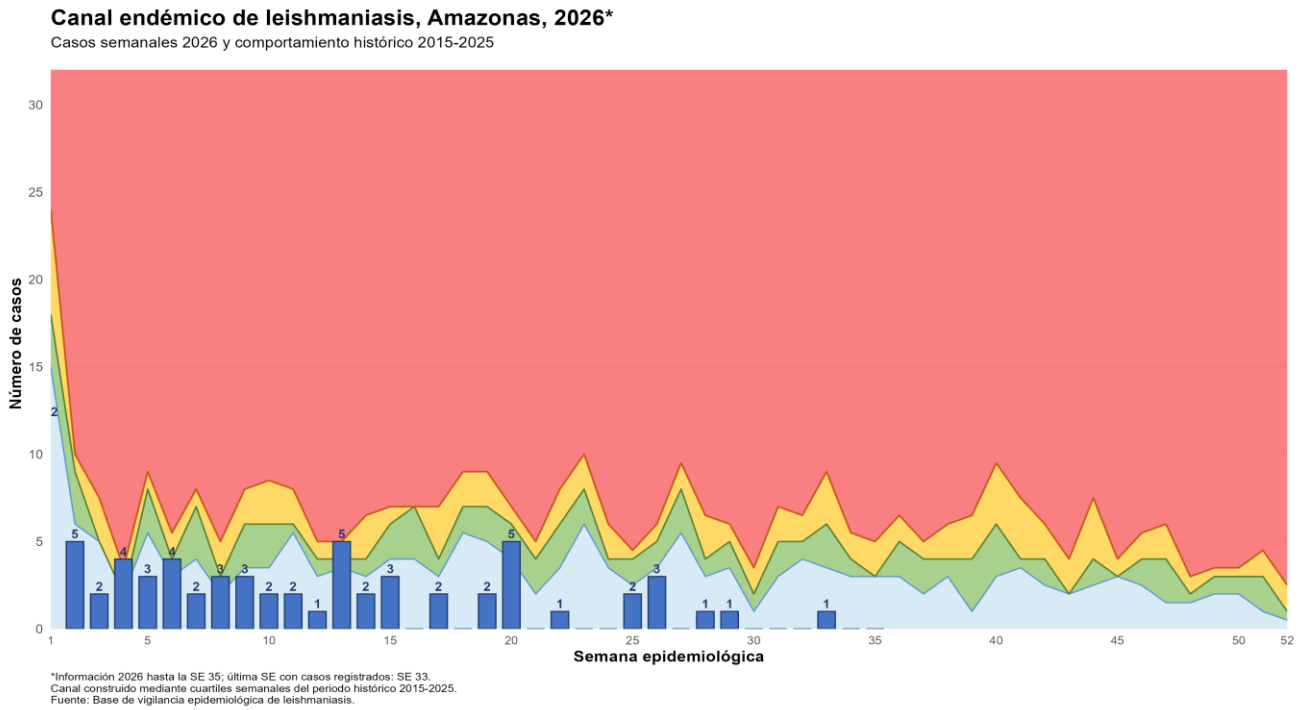
Figura 1. Incidencia acumulada de leishmaniasis por distrito, Amazonas 2026*. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica, población proyectada 2026 y cartografía político-administrativa.



Nota: Infomación hasta la SE 35*
Fuente: base de vigilancia epidemiológica + población proyectada 2026 + cartografía político-administrativa.
Elaboración: Yhojar A. Pisfil-Farroñay, FETP Intermedio, Cohorte 2026.

COMPORTAMIENTO TEMPORAL

Figura 2. Canal endémico de leishmaniasis, Amazonas 2026*



*Información 2026 hasta la SE 35; última SE con casos registrados: SE 33. Canal construido mediante cuartiles semanales del periodo histórico 2015-2025. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis.

Los casos se concentraron principalmente en las primeras semanas de 2026, con un máximo de 12 casos en la SE 1. Posteriormente se observó una disminución y presentación esporádica, predominantemente dentro de los límites esperados del canal endémico, sin evidencia de incremento epidémico sostenido durante el periodo evaluado.

Características de los casos

Tabla 2. Distribución de casos de leishmaniasis según curso de vida y sexo, Amazonas 2026*

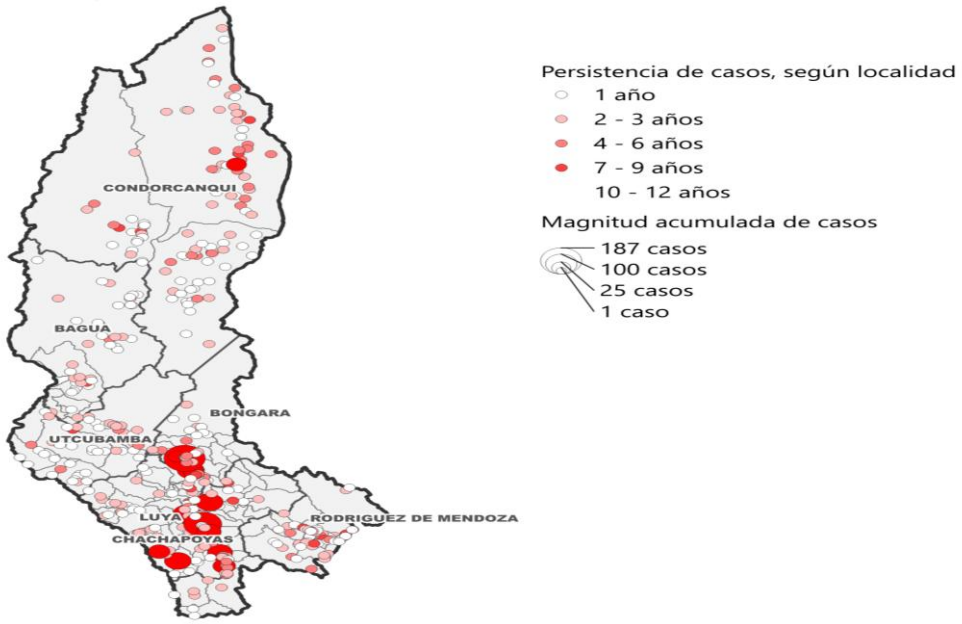
Característica	N.° casos	Porcentaje (%)
Niño (0-11 años)	7	9,9
Adolescente (12-17 años)	10	14,1
Joven (18-29 años)	12	16,9
Adulto (30-59 años)	27	38,0
Adulto mayor (60 años a más)	15	21,1
AMAZONAS	71	100,0
Masculino	39	54,9
Femenino	32	45,1

*Hasta la SE 35-2026. No se presenta TIA específica por curso de vida o sexo al no disponer en los archivos analizados de denominadores poblacionales validados para estas categorías. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis.

Los casos se presentaron en todos los cursos de vida, con predominio en adultos de 30 a 59 años (38,0 %), seguidos de adultos mayores (21,1 %). Se observó ligero predominio del sexo masculino (54,9 %).

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y PRIORIZACIÓN

Figura 3. Distribución espacial, magnitud y persistencia de la leishmaniasis, Amazonas 2015-2026*

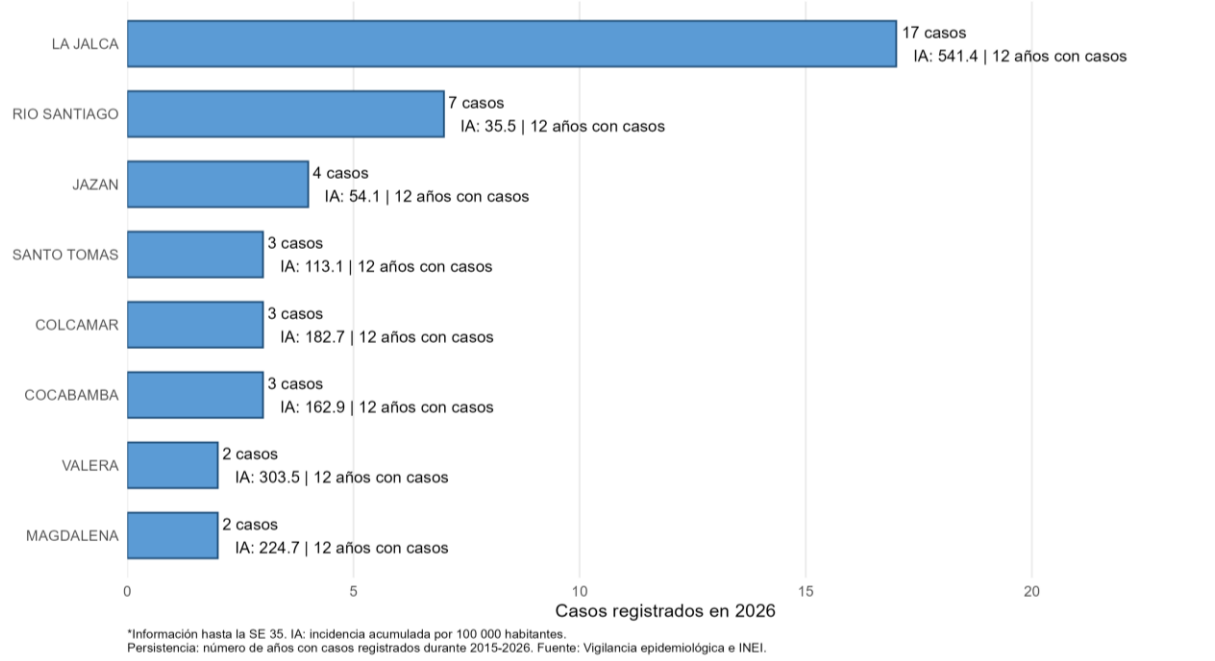


Fuente: Base de vigilancia epidemiológica de leishmaniasis, Amazonas 2015-26, SE 35*. Cartografía de centros poblados y límites político-administrativos.
Elaboración: Yhojar A. Pisfil-Farroñay, FETP Intermedio, Cohorte 2026.

*2026 hasta la SE 35. El tamaño del punto representa magnitud acumulada y la intensidad del color, años con casos registrados. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica y cartografía de centros poblados y límites político-administrativos.

Durante 2015-2026 se identificaron 465 localidades con al menos un caso registrado. La distribución fue amplia y heterogénea, con localidades que presentaron recurrencia durante varios años. La mayor magnitud y persistencia se concentró principalmente en territorios de Bongará, Luya y Chachapoyas.

Figura 4. Territorios prioritarios para leishmaniasis, Amazonas 2026*

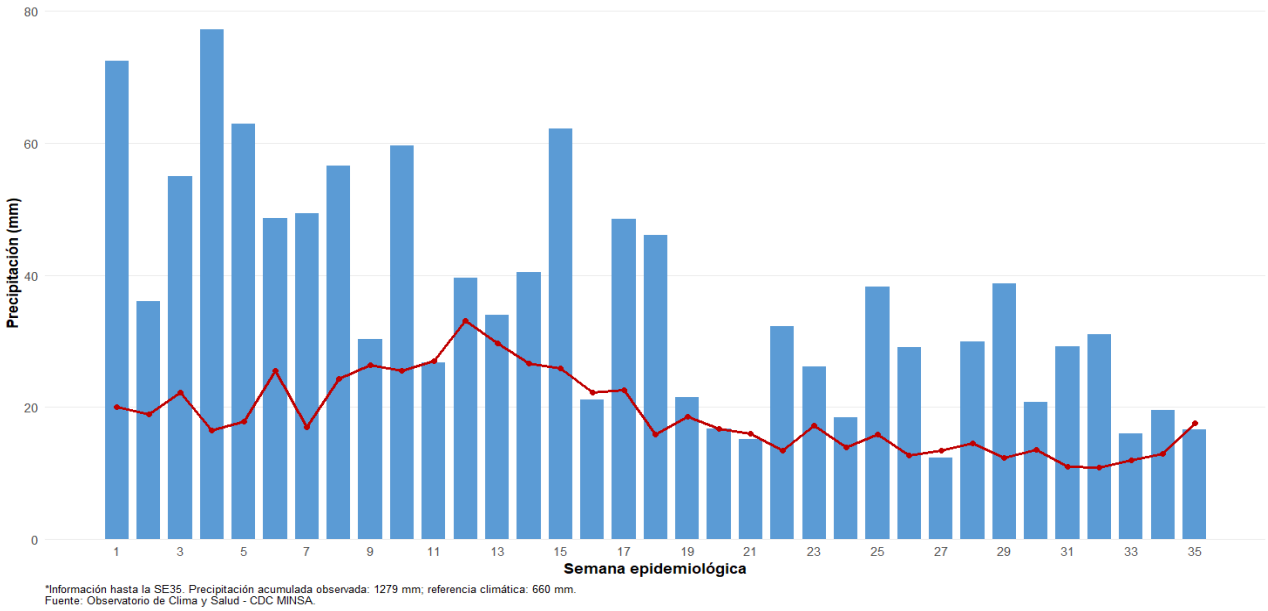


Priorización descriptiva considerando casos registrados en 2026, incidencia acumulada y persistencia histórica de casos. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica y población proyectada 2026.

La Jalca destacó como principal territorio prioritario al concentrar 17 casos, una TIA de 541,4 por 100 000 habitantes y registros durante los 12 años evaluados. Otros distritos combinaron menor magnitud actual con elevada incidencia o persistencia histórica.

CONTEXTO CLIMÁTICO Y VIGILANCIA

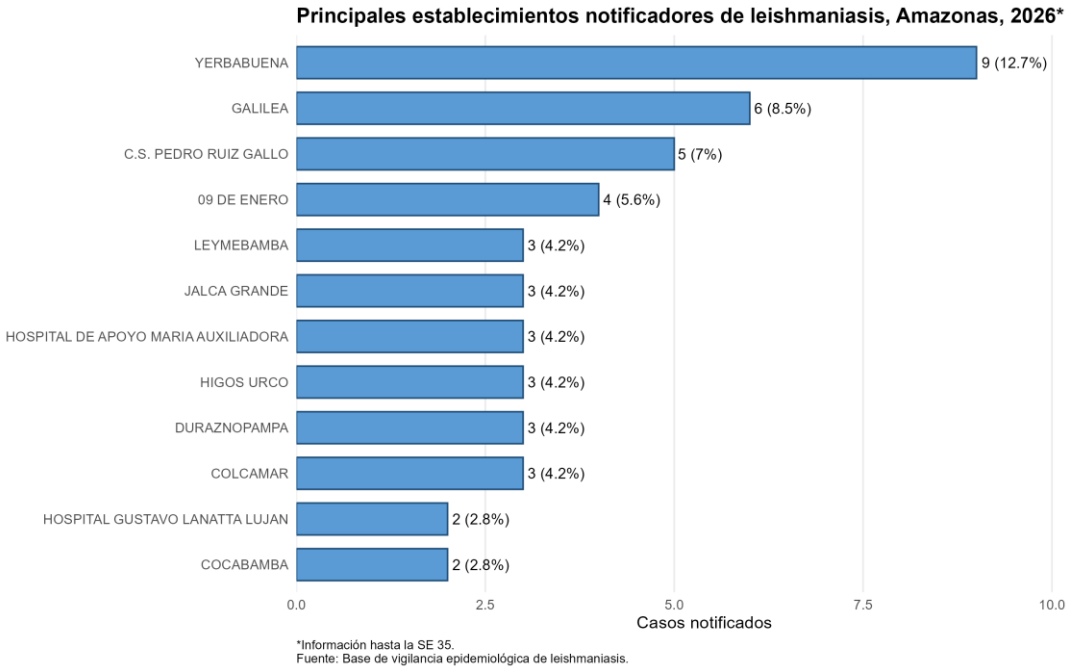
Figura 5. Precipitación semanal observada y referencia climática, Amazonas 2026*



*Información hasta la SE 35. Precipitación acumulada observada: 1 279 mm; referencia climática: 660 mm. Fuente: Observatorio de Clima y Salud - CDC MINSA.

Entre las SE 1-35 de 2026, la precipitación acumulada fue de 1 279 mm, casi el doble de la referencia climática del mismo periodo (660 mm). Las mayores diferencias se observaron principalmente durante las primeras semanas del año. Este análisis es descriptivo y no establece asociación causal con la ocurrencia de casos.

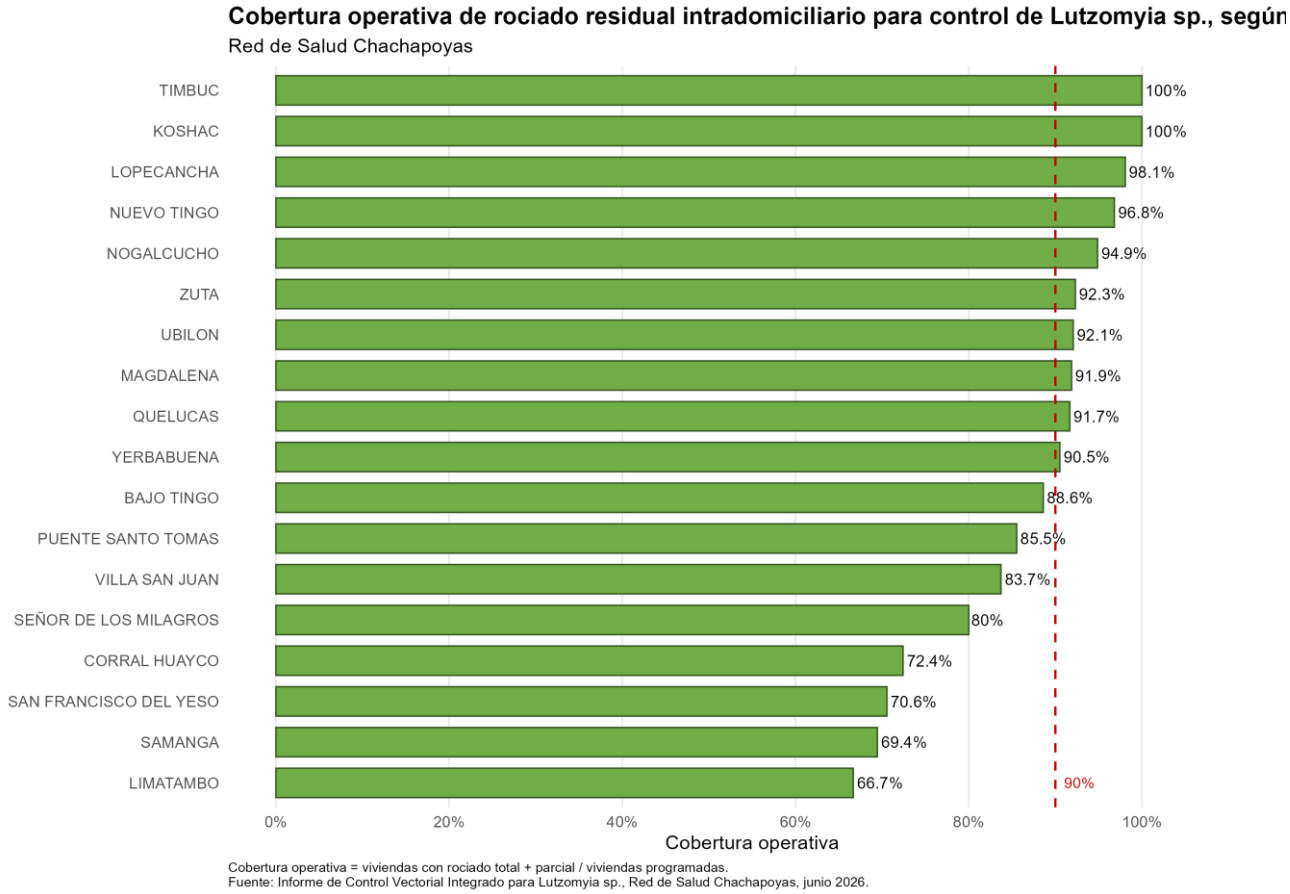
Figura 6. Principales establecimientos notificadores de leishmaniasis, Amazonas 2026*. Fuente: Base de vigilancia epidemiológica.



La notificación se distribuyó entre 36 establecimientos, con mayor aporte de Yerbabuena, Galilea y C.S. Pedro Ruiz Gallo. La mediana entre inicio de síntomas y notificación fue de 36 días (RIQ: 23-63,5; rango: 0-195 días), lo que evidencia una demora relevante en la captación o notificación.

En la revisión de calidad se identificaron 50 de 71 registros con fecha de investigación anterior a la fecha de notificación; por ello, el intervalo notificación-investigación no fue utilizado como indicador de oportunidad.

Figura 7. Cobertura operativa de rociado residual intradomiciliario para control de Lutzomyia sp., según localidad, Red de Salud Chachapoyas, junio 2026



Fuente: Informe de Control Vectorial Integrado para Lutzomyia sp., Red de Salud Chachapoyas, junio 2026.

La intervención comprendió 18 localidades del ámbito de la Red de Salud Chachapoyas. Se programaron 1 905 viviendas y se reportaron 1 697 viviendas con intervención total o parcial, equivalente a una cobertura operativa de 89,1 %. La cobertura por localidad fue heterogénea, con valores entre 66,7 % y 100 %.

La información disponible corresponde a una intervención específica de la Red de Salud Chachapoyas y no representa la cobertura de control vectorial de todo el departamento. El informe revisado no incluye mediciones de densidad vectorial, distribución de especies ni evaluación entomológica pre y post intervención.

III. Conclusiones

- Hasta la SE 35-2026 se registraron 71 casos de leishmaniasis en Amazonas, todos de forma cutánea; 93,0 % fueron confirmados y la TIA departamental fue de 16,5 por 100 000 habitantes.
- La ocurrencia fue territorialmente heterogénea. La Jalca concentró la mayor carga (17 casos) y la mayor TIA distrital validada (541,4 por 100 000 habitantes), mientras que otros distritos presentaron tasas elevadas con menor número absoluto de casos.
- Los casos de 2026 se concentraron principalmente al inicio del año y posteriormente mostraron un comportamiento esporádico, sin incremento epidémico sostenido en el canal endémico analizado.
- Se identificaron brechas de oportunidad y calidad de la vigilancia, destacando una mediana de 36 días entre inicio de síntomas y notificación y 50 registros con inconsistencias en la secuencia de fechas de investigación y notificación.
- La respuesta vectorial documentada alcanzó 18 localidades de la Red de Salud Chachapoyas; se requiere complementar la información operativa con vigilancia entomológica actualizada para orientar la respuesta territorial.

IV. Referencias bibliográficas

1. Abadías-Granado I, Diago A, Cerro PA, Palma-Ruiz AM, Gilaberte Y. Cutaneous and Mucocutaneous Leishmaniasis. Actas Dermo-Sifiliográficas. 2021; S0001-7310(21)00108-3. doi:10.1016/j.ad.2021.02.008.
2. Oryan A, Akbari M. Worldwide risk factors in leishmaniasis. Asian Pac J Trop Med. 2016;9(10):925-932. doi:10.1016/j.apjtm.2016.06.021.
3. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Boletín Epidemiológico del Perú. SE 29-2026. Lima: CDC MINSA; 2026.
4. Red de Salud Chachapoyas. Informe de Control Vectorial Integrado para Lutzomyia sp. en el corredor del río Utcubamba, junio 2026. Chachapoyas; 2026.

Elaborado por: Yhojar A. Pisfil-Farroñay, MD
FETP Intermedio - Cohorte 2026